

VÓMITOS

Jaime Madroñal Menéndez, Alba González González, Patricia Méndez Da Cuñá, Ulises Oswaldo Cabrera Urbina, Einsten Domingo León Méndez.

INTRODUCCIÓN

Náuseas (sensación desagradable de vómito inminente), arcada (contracciones espasmódicas de la musculatura abdominal) y vómito (expulsión forzada y enérgica del contenido gástrico por la boca).

Etiología

- Digestivas: infecciones, patología gástrica, patología hepatobiliar y pancreática, obstrucción intestinal enfermedades inflamatorias, etc.
- No digestivas: fármacos, patología neurológica, patología cardiovascular, patología endocrinometabólica, patología nefrourológicas, trastornos psiquiátricos y otros.

DIAGNÓSTICO

Anamnesis Minuciosa

- Aspectos generales: antecedentes medico-quirúrgicos y ginecológicos (FUR), fármacos, alcohol y drogas, viajes, enfermos en el entorno.
- Características del vómito: sangre (HDA), bilis (obstrucción alta), alimentos no digeridos (estasis esofágicas o psicógeno), fecaloideo (obstrucción intestinal).
- Aparición temporal: matutinos (embarazo, OH, uremia), durante la ingesta (psicógeno o úlcus yuxtapilórico), horas después del ayuno (obstrucción pilórica, dismotilidad).
- Tiempo de evolución: < 2 días (GEA, fármacos nuevos), > 1 mes (psicógeno, gastroparesia, pseudoobstrucción intestinal).
- Síntomas acompañantes: dolor abdominal, fiebre, diarrea, pérdida ponderal, dolor precordial, cefalea, déficit neurológico, vértigo...

Exploración

- Debe valorarse la gravedad del cuadro, prestando atención a las constantes vitales y al nivel de hidratación
- Exploración abdominal (inspección, auscultación, palpación y percusión) que incluya inspección, auscultación de la peristalsis, palpación para localizar dolor o posibles masas y descartar signos de irritación peritoneal sugestivos de un abdomen agudo y la percusión.
- En caso de sospecha, se realizará un tacto rectal para descartar de fecaloma u objetivar sangre, moco o pus en las heces.
- Debe realizarse, además, una exploración por aparatos, incluyendo exploración neurológica.

NO OLVIDAR!

- Realizar anamnesis y exploración física para descartar causas no digestivas del síndrome emético (procesos intracraneales, patología cardiovascular, etc.).

Pruebas Complementarias En Urgencias:

- **Hemograma.**
- **Bioquímica** con glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, bilirrubina total y fraccionada, GOT, GPT, GGT, LDH, amilasa y lipasa (sospecha de pancreatitis), calcio (descartar hipo/hiperparatiroidismo) y marcadores de daño miocárdico: troponina ultrasensible, CKmb si

sospecha de cardiopatía isquémica.

- **Sistemático y sedimento de orina** y test de embarazo (mujer fértil).
- **ECG.**
- **Gasometría venosa** si vómitos abundantes.
- Según sospecha se puede añadir:
 - Rx de tórax y abdomen (obstrucción intestinal).
 - Gasometría arterial (signos de gravedad).
 - Ecografía abdominal (patología bilio-pancreática).
 - Gastroscoopia (patología digestiva alta).
 - TAC cerebral (focalidad neurológica)
 - Niveles plasmáticos de fármacos (digoxina, teofilina).

TRATAMIENTO

¡ALERTA!

- Estar pendiente de las posibles complicaciones: deshidratación, alcalosis metabólica, hipoclorémica, hipopotasémica, broncoaspiración Síndrome de Böerhaave (rotura esofágica) o de Mallory-Weiss (laceración de mucosa esofágica).
- Descartar patología médica o quirúrgica urgente, deshidratación y malnutrición graves, complicaciones y ausencia de respuesta satisfactoria al tratamiento, que serán subsidiarios de ingreso.
- La reposición hidroelectrolítica se realizará en función del grado de deshidratación y la tolerancia. Siempre tratar de determinar la causa subyacente para instaurar el tratamiento específico.
- Tratamiento sintomático de los vómitos. Inicialmente, se utilizan medidas higiénico-dietéticas, pero en caso de persistencia de vómitos, se debe iniciar tratamiento antiemético (varios fármacos según etiología, tabla 1).

Fármaco	Dosis y vía	Etiología
Metoclopramida	10 mg/8h vo/im/iv	Gastroparesia Migrañas
Domperidona	5 mg/8 h vo	Dispepsia funcional
Cleboprida	0,5 mg/8 h vo	Gastroenteritis
Ondansetrón	8 mg/12 h vo/iv diluidos en 100 cc	Quimioterapia Gastroenteritis
Difenhidramina	2 mg/8 h vo 5 mg im/iv	Trastornos laberínticos
Clorpromazina	10-25 mg/4h vo/im/iv	Fármacos y anestésicos
Dexametasona	4 mg/8 h iv	Hipertensión intracraneal
Metilprednisolona	0,5-1 mg/kg vo/iv	Hipertensión intracraneal

Fármacos antieméticos

BIBLIOGRAFÍA

- López Nogueras MA, Alcántara Torres M, Repiso Ortega A. Nauseas y vómitos. En: Julián Jiménez A. Manual de Protocolos y Actuación en Urgencias. 4ª ed. Toledo: Complejo Hospitalario de Toledo, Hospital Virgen de la Salud; 2014.

- Balboa Rodríguez A, Bixquert Jiménez M. Gastroparesia, náuseas, vómitos, hipo y bezoar. En: Ponce J, Castells Garangou A, Gomollón García F. Tratamiento de las enfermedades gastroenterológicas. 3ª ed. Barcelona: Elsevier Doyma; 2011.
- Longstreth GF. Approach to the adult with nausea and vomiting. En: UpToDate [Internet]. Talley NJ, Grover S (eds). Waltham, MA. [acceso 2 de Junio de 2018]. Disponible en: www.uptodate.com.